ACTIVIDADES FUNCIONALES

SEMANA 9

BIOMECÁNICA CLÍNICA DE LAS ALTERACIONES EN LA C.V.

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Presente.

Lic. Kevin Tejada Cuadros

LATIGAZO CERVICAL

- Conjunto de síntomas que aparecen después de un mecanismo de aceleración – desaceleración con transferencia de energía al cuello secundario a impactos entre vehículos.
- Dicho mecanismo produce lesiones en el tejido blando u óseo que da lugar a gran variedad de manifestaciones clínicas. En líneas generales, se suele etiquetar de latigazo cervical a cualquier trauma que resulte en lesión musculo ligamentosa de la columna cervical.

GRADOS DE LESIÓN

GRADO 0	No existen signos ni cervicalgia.
GRADO I	Puede haber cervicalgia o rigidez pero no hay signos clínicos de lesión.
GRADO II	Cervicalgia con pérdida de recorrido articular o puntos dolorosos a la palpación (actualmente se admite grado II A sin limitación de recorrido articular o II B con limitación de recorrido articular).
GRADO III	GRADO II + presencia de lesión neurológica. Afectación de reflejos osteotendinosos o alteraciones sensitivas motoras
GRADO IV	Síntomas en cuello y Fx o Lx cervical. Tratamiento Qx.

SÍNTOMAS ASOCIADOS

- Dolor cervical
- Debilidad
- Cefaleas
- Vértigo
- Parestesias

FISIOPATOLOGÍA

Hiperextensión aguda de la columna cervical por aceleración brusca (causado por un choque posterior), seguida de una hiperflexión por efecto rebote.

Afectación de: ECOM, escalenos, largos del cuello

Lesiones primarias:
Compresión discal
Distensión o ruptura del LLA
Ruptura del anillo fibroso
Desinserción del platillo tibial superior e inferior
Compresión de raíces y arteria vertebral

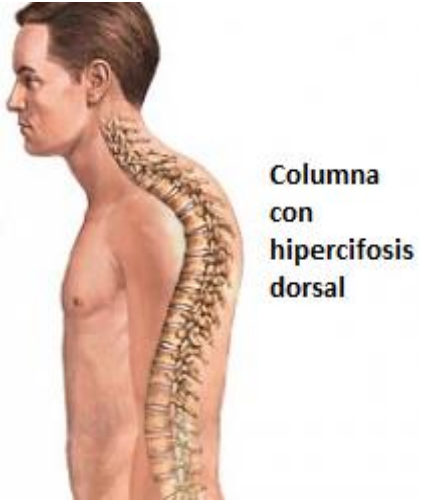
Lesiones secundarias:
Degeneraciones de los discos intervertebrales
Degeneración de las articulaciones intervertebrales
Osteofitos

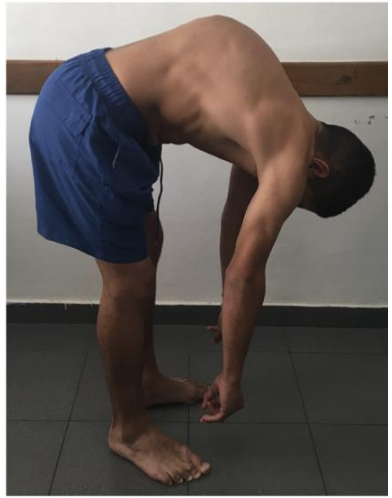
HIPERCIFOSIS

- Aumento de la curva convexa posterior en la región dorsal de la columna.

ETIOLOGÍA

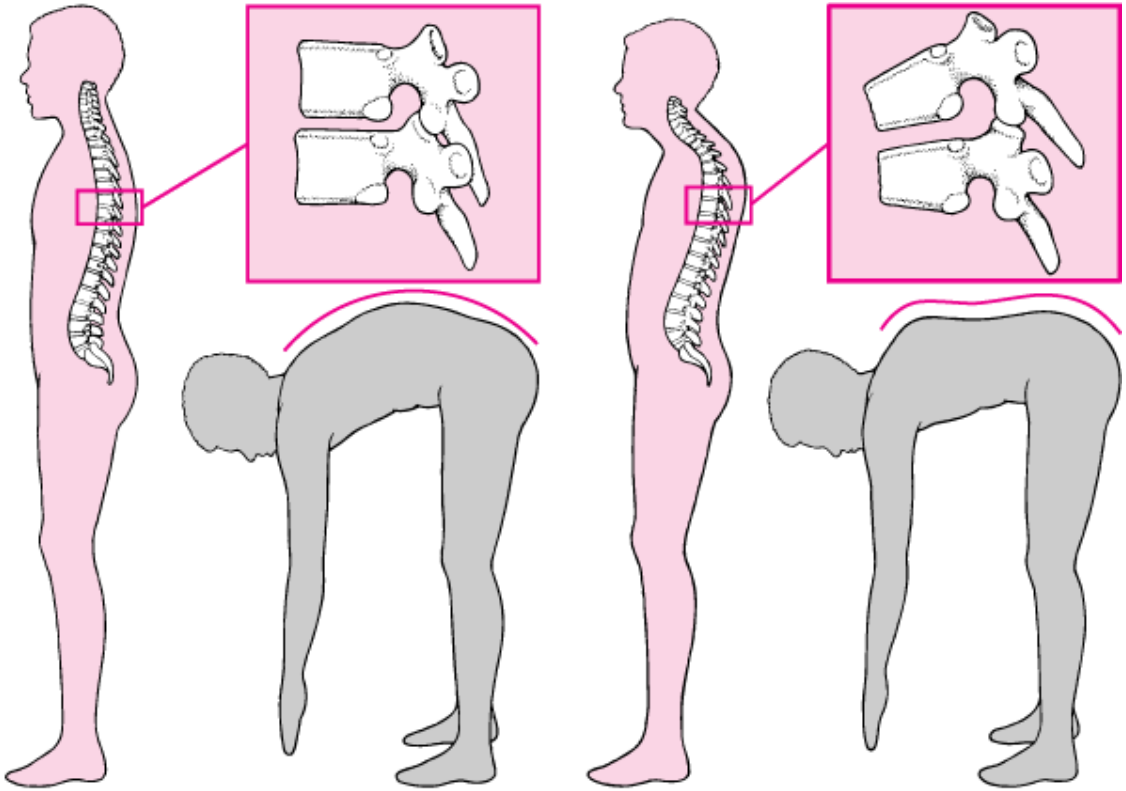
- Posturales
- Idiopáticas
- Congénitas
- Adquiridas:
  - Traumatismos
  - Metabolica, Neuogenas,
  - Distrofia congénita
  - Anomalia en MMII
  - Enfermedad de SCHEUERMANN*





BIOMECÁNICA

- Desequilibrio muscular, con predominio de los agonistas, aumentando la presión en el cuerpo y disco vertebral en crecimiento. Causando una modificación de la estructura y morfología, debido a la distribución no uniforme de la presiones.



- Vertebras en forma de cuña.
- Núcleo desplazado a posterior.
- Separación de la parte posterior de los cuerpos vertebrales.
- Distención de ligamentos, tendones, músculos situados en la convexidad y se retraen o acortan los músculos situados en la zona cóncava.
- Dolor localizado en el vértice de la curvatura. También es asintomático.
- Descenso de las costillas.
- Insuficiencia de la amplitud torácica.
- Perdida de la relación entre la parrilla costal y las escapulas.
- Proyección anterior de los hombros.

LOCALIZACION Y AMPLITUD DE LA CURVA

- Cifosis larga de gran arco, afectando a toda la columna dorsal.
- Cifosis altas, generalmente poseen un arco muy corto, comprometiendo a las últimas cervicales.
- Cifosis media.
- Cifosis baja.
- Cifosis que puede afectar a 2 regiones dorsales contiguas.

Ejercicio <<Superman>>

CIFOSIS POSTURAL (REDUCTIBLE)

Pautas generales de ejercicios posturales

- En postura de decúbito prono, extienda las manos frente a la cabeza.
- Manteniendo la cabeza en una posición neutral, mirando hacia el suelo, levante los brazos y las piernas hacia el techo.
- Siente como si estuvieras llegando lejos de tu cuerpo con tus manos y pies. Mantenga durante 3 segundos y repita 10 veces.

7 MEJORES
EJERCICIOS
HIPERCIFOSIS
DORSAL

ESTENOSIS LUMBAR

- Se produce cuando los espacios en la columna vertebral se reducen y ejercen presión en la médula espinal y raíces nerviosas.
- El estrechamiento se produce a lo largo del tiempo.
- La posibilidad de presentar el trastorno aumenta a medida que la persona envejece.
- Puede darse en jóvenes que nacen con un conducto vertebral reducido o que sufren una lesión en la columna lumbar.

SÍNTOMAS

- Dolor en el área lumbar de la espalda.
- Dolor o ardor que se extiende a los glúteos y las piernas, y que generalmente empeora al ponerse de pie o caminar, y mejora al inclinarse hacia adelante.
- Adormecimiento, hormigueo o calambres en las piernas y los pies que pueden empeorar al ponerse de pie o caminar.
- Debilidad en las piernas y los pies.

CAUSAS

- El envejecimiento y los cambios en la columna vertebral relacionados con la edad ocurren con el tiempo y lentamente ocasionan estenosis espinal.
- La artritis es otra causa frecuente de la estenosis espinal. Dos formas de artritis que pueden afectar la columna vertebral son la osteoartritis y la artritis reumatoide.
- Otras afecciones como tumores en la columna vertebral, fracturas por lesiones u otros problemas médicos y la enfermedad ósea de Paget también pueden causar estenosis espinal.

¿CÓMO SE TRATA?

- Tratamientos no quirúrgicos, que pueden aliviar el dolor e incluyen fisioterapia, un aparato ortopédico para brindar apoyo.
- Medicamentos para ayudar a aliviar el dolor y la inflamación.
- Cirugía, según los síntomas, cómo responde a otros tratamientos y el estado general de salud.

SACROILEITIS

- Dolor producido en la articulación sacro-ilíaca, generada por factores de estrés mecánico.
- Es una causa subdiagnosticada del dolor lumbar crónico no radicular, que afecta entre el 15% y 30% de los casos.

ETIOLOGÍA

- Los mecanismos de daño son por la combinación entre carga axial y rotación, siendo la ASI más vulnerable que la columna lumbar a ambas.
- La mitad de las causas son idiopáticas o por microtrauma, debidas a excesiva tensión de los ligamentos que aseguran la coaptación ASI, dolor por estrés mecánico de la cápsula y ligamentos de la ASI durante el embarazo, actividades deportivas o fusión lumbosacra.

Intraarticular	Extraarticular
Artritis: reumatoide y psoriática	Lesión ligamentosa
Pelviespondilopatías	Fracturas óseas
Cáncer	Cáncer
Trauma	Dolor miofascial
Infección: estafilococia, brucelosis, tuberculosis	Entesopatía
Enfermedad quística	Trauma embarazo

ETAPAS

ETAPA AGUDA: 1 – 3 DÍAS	El manejo incluye reposo relativo, aplicación de hielo/ movilización con calor, antiinflamatorios no esteroidales.
ETAPA DE RECUPERACIÓN: 3 DÍAS – 8 SEMANAS	El tratamiento consiste en movilización articular y terapia física.
ETAPA DE MANTENCIÓN	Tratamiento dirigido a corregir la dinámica postural. Una vez que el dolor ha cedido, intentar restaurar la mecánica normal.

TRATAMIENTO REHABILITADOR

- Los objetivos de la terapia física son:
- Aliviar el dolor, eliminando sus generadores.
- Aumentar la coaptación y estabilidad ASI, fortaleciendo la musculatura del cuádriceps, abdominales, isquiotibiales.
- Mejorar déficits de flexibilidad, propiocepción, fuerza y problemas biomecánicos; desbalances mal adaptativos, corrigiendo los mecanismos lumbo-pélvicos y de cadera.
- Mejorar control postural dinámico.
- El programa de ejercicios diseñados para aliviar el dolor y corregir los problemas biomecánicos debería ser titulados individualmente. El único punto validado en kinesiterapia es tener cuádriceps, abdominales e isquiotibiales bien desarrollados, necesarios para asegurar la coaptación y estabilidad de la articulación sacroilíaca, y que ellos controlan activamente.

SACROILEITIS
sacroileítis sea la

Gracias por su atención